Bevezetés 3.
Az intézeti címek 2007. évi költségvetésének szöveges indoklása 7.
1. cím Egészségügyi Minisztérium Igazgatása
1.1 Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása 7.
1.2 Egészségügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 7.
2. cím Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Hivatal
2.1. Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 8.
3. cím Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dok. központok… 10.
4. cím Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei 10.
5. cím Országos Mentőszolgálat 12.
7. cím Országos Vérellátó Szolgálat 13.
8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 13.
10. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 14.
10.1 Beruházás
10.1.1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 14.
10.1.7 Országos Sportegészségügyi Intézet I. ütemének beruházása 15.
10.1.8 Egyéb beruházások 16.
10.2. Egészségügyi ágazati célelőirányzatok
10.2.1 Oltóanyag beszerzés 16.
10.2.2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 17.
10.2.3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 21.
10.2.4 Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok 22.
10.2.9 Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások 22.
10.2.11 Regionális ágazati feladatok ellátása 22.
10.2.12 Határon túli magyarok egészségügyi feladatinak támogatása 23.
10.2.13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 23.
10.2.41 Intézményi felújítás 24.
10.11 Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek
10.11.1 A nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 24.
10.17 Köztestületek támogatása
10.17.1 Magyar Orvosi Kamara 24.
10.17.2 Magyar Gyógyszerész Kamara 25.
10.17.3 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 25.
10.20 Társadalmi szervezetek támogatása
10.20.10 Magyar Vöröskereszt 25.
10.20.11 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 26.
10.20.18 Rákbetegek szervezetei 26.
10.22 Tartalék
10.22.1 Fejezeti tartalék 26.
10.22.2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 26.

BEVEZETÉS

Az Egészségügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozik az egészségügyi ellátórendszer – ide értve a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat is - összehangolt működésének biztosítása, melyet jogszabályok és szakmai szabályok kidolgozása útján valósít meg. A fejezet intézményei részt vesznek a gyógyító-megelőző munkában, a rehabilitációban, ellátják a vérellátás, a mentés, a megelőzés, a közegészségügy, valamint a járványügy országos feladatait.
A 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet értelmében az egészségügyi miniszter a Kormánynak az egészségügyért és az egészségbiztosításért felelős tagja.

A Kormány által meghirdetett „Az Új Egyensúly programja 2006-2008.", fordulatot hozott a hosszabb távon megvalósuló gazdaságpolitikában, valamint azonnali feladatként az egészségügy átalakítását rendelte el. A program megfogalmazta az egészségügy átalakításának alapvető elveit, melyben elkötelezte magát az egészségügy reformja mellett. A 2006-ban megkezdett átfogó, érdemi reform azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljon az igazságtalan területi különbségek kiegyenlítése, korszerű és hatékony struktúrájú ellátórendszer jöjjön létre.

A kormányzati szándék megvalósulásának alapjait képező jogalkotói munka döntően a 2006. évi, 2007-ben hatályba lépett törvényalkotásra épül. A reformtörvények elfogadása, így különösen a gyógyszergazdaságosságról, a gyógyszerellátás minőségének javítása érdekében szükséges intézkedésekről, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről, az Egészségbiztosítási Felügyelet létrehozásáról, valamint a kamarák szerepének újrafogalmazásáról, a reform első, azt megalapozó lépései voltak. Eredményeként csökkent a felesleges orvos-beteg találkozás, megszűnt a gyógyszerkassza hiánya és 2008-ra, a hatálybalépés időpontjára, rendeződik a helyzet a biztosítási jogviszonyok tekintetében is.

A struktúraátalakítás, melynek kedvező pénzügyi hatásai már 2007-ben is megmutatkoztak, 2006-ban 6,5 milliárd Ft, míg 2007-ben 7,5 milliárd Ft összegű, az E-Alap terhére történő pályázattal lett elősegítve. A többletforrás az ágyszámcsökkentés, az új struktúra kialakítását elősegítő beruházások, valamint az új körülményekhez igazodó munkaerő-gazdálkodás megvalósulásának támogatását szolgálta. A fejezet felügyelete alá tartozó intézetek vagyonkezelésében levő ingatlanok értékesítéséből származó bevételből történő visszapótlási kötelezettség mellett, a központi költségvetés általános tartaléka terhére biztosított további 3,5 milliárd Ft szintén az ágazati egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatokra kerül felhasználásra. A fejlesztések ellátásra gyakorolt hatása alapvetően 2008-ban fog jelentkezni.

Az Egészségügyi Minisztériumnál az egészségügyi reform keretében belül számos olyan intézkedésre, jogszabályváltozásra került sor, amely jelentősen befolyásolja a tárca gazdálkodását is.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben (Eftv) rögzített elvek alapján kerültek felosztásra a szakellátási normatívák. Az elsődlegesen felelős RET-ek döntésének hiányában, az Eftv. 2. sz. mellékletében meghatározott normatíva felosztásáról, az egészségügyi miniszter intézményenként egyedi közigazgatási határozatok formájában hozta meg döntését és rendelkezett egyes gyógyító intézmények aktív-, és krónikus fekvőbeteg-kapacitásairól.

A közigazgatási határozatok a tárca felügyelete alá tartozó egyes gyógyító-megelőző intézmények tekintetében nulla kapacitásról rendelkeztek, ami azt jelenti, hogy az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetnek, a Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézetnek, az Országos Gyógyintézeti Központnak és a Parádfürdői Állami Kórháznak teljesen megszűnt a közfinanszírozott aktív és krónikus fekvőbeteg-kapacitása. Döntés született arról is, hogy az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet központi költségvetési intézményként történő megszüntetését követően a Péterfy Sándor utcai Kórházzal összevonásra kerül.

A megszűnő intézmények egyes feladatait részben a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézetei, úgy, mint a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet, Szent Margit Kórház (illetve jogutódja), valamint a fejezet egyes intézetei, pl: az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, az Országos Vérellátó Szolgálat, az Országos Tisztifőorosi Hivatal, illetve az Állami Egészségügyi Központ veszi át.
Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakítások és intézkedésről szóló 2118/2006.(VI.30.) Kormány határozat alapján végrehajtásra kerültek, illetve kerülnek továbbá

- az OTH és az OMMF között a munkaegészségügyi feladatok (OMFI + ÁNTSZ megyei szervezetei) átadása;
- a 7/2007.(III.19.) MeHVM rendelet alapján a tárca részéről munkakörnyezettel és infrastruktúrával összefüggő feladatok átadása a MeH Központi Szolgáltatási Főigazgatósága részére;
- a 2006. évi CXVI. törvény elfogadásával 2007. február 1-i hatállyal megalakult a kormányhivatalként működő Egészségbiztosítási Felügyelet;
- az Országos Gyógyintézeti Központ megszüntetésével a két, részben önállóan gazdálkodó intézet (Országos Gyermekegészségügyi Intézet és az Országos Addiktológiai Intézet) integrálása az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz;

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fő felelőssége mellett működő és 2007. október 1., illetve egyes feladatok tekintetében július 1. napjától létrejövő egységes élelmiszer-biztonsági rendszer érinti a fejezet intézeteit is. Az FVM felügyelete alá került a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal, valamint az ÁNTSZ regionális intézeteinek feladatköréből kikerülnek az élelmiszerbiztonsági feladatok.

Az elmúlt években az ÁNTSZ cím, OTH és intézményei alcím előirányzatai között szerepelt az oltóanyag ellátás biztosítása. 2008-tól e kiadások fedezete a fejezeti kezelésű előirányzatok között kerül megtervezésre. A 4.800 millió Ft előirányzatból térítésmentesen kerülnek biztosításra az életkorhoz között kötelező védőoltások, a megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokhoz szükséges oltóanyagok, valamint az influenza elleni oltóanyag, a veszélyeztettek számára.

Az egészségügy széles területét érintő szakmai és szervezeti változások mellett számos, a korábbi években megkezdett sikeres program folytatására kerül sor. A Nemzetei Rákellenes Program célkitűzésének megvalósítása, mely szerint csökkenjen a daganatos betegek száma, javuljon túlélési esélye, a szűrővizsgálatoknál kezdődik, ezért a népegészségügyi szűrővizsgálatra 2008-ban is rendelkezésre állnak költségvetési források.

A 2007-től a fejezet költségvetésében kerül megtervezésre a külföldön élő, magyar nemzetiségű külföldi állampolgárok egyes Magyarországon történő egészségügyi ellátásai költségéhez való hozzájárulás fedezete. A környező országok uniós tagságára való tekintettel már csak a Szerbiában és Ukrajnában élő magyar nemzetiségűek egészségügyi ellátása kerül támogatásra.

A 2207/2005. (X.5.) Korm. határozatban adott felhatalmazás alapján, a 2006-ban lebonyolított, elavult aneszteziológiai géppark megújítására tartós bérleti konstrukció formájában került sor. A 8 éves időtartamú bérleti szerződés bérleti díja a fejezet költségvetésében szerepel.

Költségvetési forrás áll rendelkezésre a nemzetközi kapcsolatokból adódó pénzügyi kötelezettségekre, néhány társadalmi szervezet támogatására.

A 2008. évi költségvetés tervezési irányelveinek megfelelően intézeti körben a létszám tervezése során figyelembevételre került

- az egészségügyi struktúraváltással összefüggő létszámváltozás,
- az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódó intézkedések hatása,
- az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2131/2007. (VII. 26.) Korm. határozat keretében elismert létszámemelkedés,
- a hatékony munkaszervezési intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentés,
- a feladatok átszervezésével összefüggő változások, továbbá a többletfeladatok miatti létszámemelkedés.

A személyi juttatások előirányzat tervezése során figyelembevételre került

- az egészségügyi struktúraváltással összefüggő előirányzat változás,
- az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódó intézkedések miatti változás,

- az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél megvalósuló létszámcsökkentéssel összefüggő megtakarítás 2008. évi hatása,
- az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél a 2007. évre számított és a tényleges megtakarítás közötti eltérés visszarendezése,
- a teljesítményalapú és teljesítményösztönző bérrendszer kialakításával összefüggő intézkedés hatása,
- a 2007. évben végrehajtott illetményjavítás hatása és szintrehozása, a törvényi kötelezettségek miatti előirányzat-emelkedés, amelynek forrása intézeti többletbevétel,
- a feladatok átszervezésével, az intézeti szervezési intézkedések, a többletfeladatokkal összefüggő előirányzat változás / emelkedés.

Az elkövetkezendő években EU-s források bevonását kívánjuk biztosítani a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, Társadalmi Operatív Program, ROP, KMR OP pályázati keretekben.
A pályázati források kiterjednek az alap-, járóbeteg és fekvő szakellátás intézményrendszerek fejlesztésére, a sürgősségi ellátás (mentés, légimentés, gyermeksürgősségi ellátás) fejlesztésére, onkológiai ellátás infrastrukturális fejlesztésére, melyekre 2008-ban mintegy 247,0 milliárd Ft összeget tervezünk.

Az intézeti címek 2008. évi költségvetésének szöveges indoklása

A tárca felügyelete alá tartozó intézmények kiadási előirányzata 106.277,3 millió forint, támogatási előirányzata 33.577,4 millió forint, bevételi előirányzata 72.699,9 millió forint.

1. cím Egészségügyi Minisztérium Igazgatása

Az 1. cím 1. alcímhez az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező EüM Központi Igazgatása, a 2. alcímhez a részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EKH) tartozik.

1.1. Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása /EüM.GI/

A minisztérium - elsősorban jogalkotás útján - ágazati irányító jogkört gyakorol az egészségügy valamennyi területét érintő kérdésekben, és felügyeleti jogot gyakorol az általa alapított központi költségvetési szervek felett. A miniszter irányítja, összehangolja és szervezi a társadalombiztosítással kapcsolatos egészségpolitikai feladatokat is.

A közigazgatás átalakításával összefüggésben a munkakörnyezettel és infrastruktúrával összefüggő /ezen belül az üzemeltetési, karbantartási, fejlesztési/ feladatok átkerültek a Központi Szolgáltatási Főigazgatósághoz.

A támogatási előirányzat mértéke 1.725,9 millió forint, ami az előző évhez viszonyítva 278,2 millió forinttal alacsonyabb.

A 2118/2008. Kormány határozat alapján a MeH-KSZF és EüM közötti feladat átadásával az állami támogatás 432,4 millió forinttal, a bevételi előirányzat 39,7 millió forinttal, a létszám 27 fővel csökken.
A 2135/2007.(VII.17.) Kormány határozat értelmében a teljesítményalapú és teljesítményösztönző bérrendszer (TÉR) kialakítására kapott támogatási többlet 154,2 millió forint.

A tervezhető létszámkeret 217 fő.

1.2. Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal /EKH/

Az EKH központi hivatalként működő, jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Feladatköre: az állami, hatósági feladat keretében, az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartások vezetése, hatósági, ellenőrzési feladatok ellátása, továbbá az egészségügyi szakértői engedélyek, gyógyászati felhasználással rendelkező kábítószerek és pszichotrop anyagokkal végzett tevékenységek engedélyeinek

kiadása, a külföldön szerzett egészségügyi diplomák, szakképesítések, felsőfokú szakirányú szakképesítések elismerése, honosítása.

Az állami támogatás tervezett előirányzata 125,3 millió forint, ami 33,5 millió forinttal magasabb az előző évinél. A 2047/2007.(III.19.) Kormány határozat alapján EKH-hoz kerülő feladatokra (Magyar Orvosi Kamara által korábban ellátott országos regisztráció és iratanyag kezelése) 35,7 millió forint támogatást (ezzel együtt 7 fő létszám fejlesztést) kap az intézet. A 2,2 millió forintos csökkenést az igazgatási és igazgatásjellegű tevékenységet ellátó intézetek létszámcsökkentésével összefüggő 2117/2006.(VI.30.) Korm. határozat végrehajtása, a tényleges kiadásváltozás közötti különbözet rendezése indokolja.

A tervezhető létszámkeret 26 fő.

2. cím Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

2.1. Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei

A címhez tartozó költségvetési szervek

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:

- *Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat 7 regionális intézete*
- *Országos Epidemiológiai Központ*
- *Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet*
- *Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ*
- *Országos Egészségfejlesztési Intézet*
- *Országos Kémiai Biztonsági Intézet*
- *Országos Frederic Joliot Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet*
- *Országos Környezet-egészségügyi Intézet*
- *Országos Alapellátási Intézet,*
- *Országos Gyermekegészségügyi Intézet*
- *Országos Addiktológiai Intézet*

A Hivatal az Állami Népegészségügyi Szolgálatról szóló 1991. évi törvényben foglalt egészségügyi célok elérése érdekében a közegészségügy (környezet-és település-, élelmezés- és táplálkozás, munka-, sugáregészségügy és sugárbiológiai, toxikológia), a járványügy (fertőző- és nem fertőző betegségek epidemiológiája), az egészségfejlesztés (egészségnevelés, egészségvédelem), az egészségügyi igazgatás és koordináció, az egészségügyi és gyógyszerellátás területén az ÁNTSZ központi irányítási, koordinálási feladatait látja el. E feladata keretében irányítja és koordinálja egészségügyi államigazgatási szerv által gyakorolt szakmai felügyeleti tevékenységet az egészségügyi szolgáltatók és a lakossági gyógyszerellátást nyújtók tevékenysége felett, az ügyeleti, továbbá a készenléti ellátás és betegbeutalás rendjének megállapítását, közzétételét, nyilvántartását ideértve a gyógyszertári ügyeletet és készenlétet is, valamint a gyógyszerellátással és a kábítószerekkel kapcsolatos

szakfelügyeletet, és a lakossági gyógyszerellátással kapcsolatos hatósági feladatokat. Ezen túl ide tartozik a gyermekegészségüggyel, a gyermekek jól-létével, ezzel kapcsolatos gyermeki jogok érvényesítésével összefüggő feladatok, továbbá az addiktológia szakterülettel összefüggő gyógyító-megelőző, szervezési, módszertani tevékenységek.

Az állami támogatás előirányzata 16.587,4 millió forint, az előző évhez képest 950,8 millió forinttal alacsonyabb.

Az OTH és az OMMF között a munkaegészségügyi feladatok (OMFI + ÁNTSZ megyei szervezetei) átadásaként a támogatás 672,2 millió forinttal (a létszám 238 fővel) csökken. Az igazgatási és igazgatásjellegű tevékenységet ellátó intézetek létszámcsökkentésével összefüggő 2117/2006.(VI.30.) Korm. határozat végrehajtása és a tényleges kiadásváltozás közötti különbözet rendezése (a 2007.évben beépített megtakarítás szintrehozása) a támogatási előirányzatnál (-)546,3 millió forint változást, a létszámleépítésből eredő 2007. évi támogatás csökkentés visszapótlása pedig 1.615,6 millió forintos emelkedést jelent.
A megszűnő Országos Gyógyintézeti Központtól átszervezett Országos Gyermekegészségügyi Intézet 196,7 millió forint (46 fő), az Országos Addiktológiai Intézet 28,2 millió forint (66 fő) támogatási előirányzattal kerül át.
Hazánkat, mint az EU tagját a 98/8 EK Irányelvekben foglaltak, valamint a 38/2003.(VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendeletben foglaltak alapján a BIOCID hatóanyagok és termékek engedélyezése, forgalmazása, a REACH terén tagállami kötelezettségek terhelik, ezen feladatok koordinálásáért az OTH felelős. Ennek megfelelően a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzetközi hatósági /BIOCID/ feladatok ellátására 42,2 millió forint (6 fő), a REACH feladatokra 56,1 millió forint (10 fő) támogatással ellentételezett fejlesztést kap az intézet. A Drog Fókuszpont működtetéséhez 20,0 millió forint, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet feladataihoz 9,0 millió forint többlettámogatást biztosítására kerül sor.
Az oltóanyag beszerzések ellentételezésére korábban biztosított (az OTH költségvetésébe már beépült 2.000,0 millió forintos) keret 2.500,0 millió forint támogatással bővül, ezzel egyidejűleg, a 4.500 millió forintra módosult célelőirányzat -a racionálisabb felhasználás érdekében- központosításra kerül a fejezeti kezelésű előirányzatok közé. Az Országos Alapellátási Intézet feladatai között a „Háziorvosi praxis" bővítése 40 fő létszámfejlesztést és 449,0 millió forint bevételnövelést eredményez. A Nemzeti Biztonsági Labor működtetése 50,0 millió forint, a Labor-akreditációval kapcsolatos feladatok ellátása 10,0 millió forint (2 fő létszám) támogatással ellentételezett fejlesztést indokol. A Schengeni határok módosításából adódó többletfeladatok kiadása 140,0 millió forint támogatást és 21 fő létszám fejlesztést igényel. A munkaegészségügyi szakhatósági feladatokra 50,0 millió forint (10 fő), tekintettel arra, hogy szakmai felügyeletet gyakorol a lakossági gyógyszerellátást nyújtók tevékenysége felett és e tevékenysége a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás ellenőrzési feladataival is bővült *50*,0 millió forint (7 fő) támogatási előirányzat biztosítható.

A létszámkeret 4 173 fő, az előzőekben ismertetett változások, átszervezések következményeként.

3. cím Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek

A címhez tartozó költségvetési szervek:

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet /ESKI
Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet /ETI

A címhez tartozó intézetek közgyűjteményi, kutatási, egészségügyi informatikai és információpolitikai feladatokat, valamint iskolarendszeren kívüli továbbképzési feladatokat, ágazati bérstatisztikai, kódrendszerek karbantartásával összefüggő, valamint (korábban Országos Egészségbiztosítási Pénztár feladatai között szereplő) technológiai elemzési, és egészségügyi közgazdasági stratégiai elemzési feladatokat.

A támogatási előirányzat 8.972,2 millió forint, ami 5,2 millió forintos növekedést jelent. Ebből az ESKI többletfeladatainak finanszírozására 2,3 millió forintot (1 fő), a Nemzeti Egészségügyi Tanács titkársági feladatok ellátására 2,2 millió forint (1 fő), támogatást került biztosításra. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet megszűnésével a Pszichológiai Szakmai Kollégium gazdálkodási keretének átrendezése 0,7 millió forinttal növeli a támogatási előirányzatot.

A tervezett létszámirányszám 225 fő, ami az előzőekben jelzett feladat bővülések és az év közben saját hatáskörben végrehajtott (4 fő) létszámcsökkentések eredménye.

4. cím Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei

A címhez tartozó költségvetési szervek:

Országos Sportegészségügyi Intézet
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet
Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet
Országos Onkológiai Intézet
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet
Mátrai Állami Gyógyintézet
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
Állami Szívkórház Balatonfüred
Állami Szanatórium Sopron
Országos Gyógyintézeti Központ
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Orvos és Kórháztechnikai Intézet
Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

Országos Gyógyszerészeti Intézet
Parádfürdői Állami Kórház

A címhez 18 önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv tartozik. Az intézetek tevékenysége többségében gyógyító-megelőző ellátással összefüggő fekvőbeteg ellátó feladatok, szanatóriumi szolgáltatások, az ezekhez kapcsolódó laboratóriumi, diagnosztikai, terápiás feladatok és a profiljukba illő kutatási tevékenységek.

Az egyes gyógyító-megelőző intézmények jövőbeni kapacitását meghatározó közigazgatási határozatok szerint a tárca felügyelete alá tartozó egyes gyógyító-megelőző intézményeknél -a nulla kapacitás miatt- teljesen megszűnik a közpénzből finanszírozott aktív és krónikus fekvőbetegek ellátás, így az érintett intézetek (OPNI 849 ágy, a Svábhegy 180 ágy, OGYK 601 ágy és a Parádfürdő 140 ágy) megszüntetésre, illetőleg feladataik több intézményhez átszervezésre kerülnek. A racionalizálás keretében az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (366 ágy) központi költségvetési intézményi státusza megszűnik, és összevonásra kerül a Péterfy Sándor utcai Kórházzal.

Az intézmények bevételi előirányzata 35.075,3 millió forint, ami az előző évhez képest 13.339,5 millió forinttal csökken.
A négy intézet megszűntetése, átszervezése 16.055,2 millió forint bevételi előirányzat törlését, 115,1 millió forint támogatás központosítását 3.137 fő létszámelőirányzat csökkentését eredményezi.
A többi intézetnél végrehajtott átszervezések, ágyszám és TVK változások további 273,4 millió forint bevételi előirányzat csökkentést jelentenek.
Az Országos Onkológiai Intézetnél a teljesítmény növelése, a Gottsegen György Országos. Kardiológiai Intézetnél az új feladatok (transzplantációs elő- és utókezelés, gyermek szívtranszplantáció) beindítása, a HBCS változás hatása 2.666,6 millió forint bevétel növekedést eredményeznek.
Az Országos Sportegészségügyi Intézetnél a sportorvosi vizsgálatoknál bevezetésre kerülő térítési bevétel 130,5 millió forint többletet, az Országos Gyógyszerészeti Intézetnél az Indikáción Túli Gyógyszerrendelési Osztály megalakítása 33,1 millió forint (8 fő létszám) fejlesztést jelent.
Az OGYK megszűnése miatt az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) és az Országos Addiktológiai Intézet (OADI) beintegrálódik az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz, ezzel egyidejűleg előirányzataik (támogatás –225,5 millió forint, bevétel –216,2 millió forint, létszám –112 fő) is átrendezésre kerülnek.
Az OGYK Diószegi úti telephelyén működő osztályok (Transzplantációs Immunológiai Osztály, Molekuláris Diagnosztikai Osztály stb.) és azok előirányzata átadásra kerül az Országos Vérellátó Szolgálathoz, melyek összességében -360,0 millió forint bevételi előirányzat és -47 fő létszám változást jelent.

Az állami támogatás előirányzata 1.913,9 millió forint, ami az előző évhez képest 42,5 millió forinttal csökken.
A változás egyrészt az OGYK megszüntetésével járó -fentiekben jelzett-átszervezésekkel (OGYEI és OADI átadása az OTH-hoz, a Pszichológiai Szakmai Kollégium előirányzatának átszervezése az ETI-hez) van összefüggésben, aminek

következményeként (a fentiekben jelzettek szerint) az állami támogatás 339,9 millió forinttal csökken.
A megszüntetésekkel járó vagyonvédelmi, eszközhasznosítási, adminisztrációs és egyéb /jogutódlás jellegű/ feladatok ellátására 92,0 millió forint támogatás (7 fő) beépítésre kerül az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet költségvetésébe. Ezen felül, az intézetek megszüntetésével összefüggő feladatok külső cég által történő ellátása további 200,0 millió forint biztosítását igényli.
Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet a légzésbénult betegek ellátásának javításához 6,0 millió forint kiegészítő támogatást kap.

A tervezhető létszámkeret 5.611 fő, ami összességében 3.511 fő csökkenést jelent. Ez egyrészt az előzőekben jelzett struktúraváltásnak, az intézetek átszervezésének, megszüntetésének eredménye, másrészt az intézeteknél saját hatáskörben végrehajtott létszámcsökkentések, illetőleg egyéb feladatváltozással összefüggő fejlesztések hatása.

5. cím Országos Mentőszolgálat

A Szolgálat feladata az ország egész területére kiterjedően az életmentés, a sürgősségi betegellátás, betegszállítás, elsősegélynyújtás ellátása, közreműködik az oxyológiai kutatómunka elvi-módszertani irányításában, részt vesz a szolgálat dolgozóinak oxyológiai szakképzésében és továbbképzésében.
A Szolgálat zavartalan működtetéséhez nélkülözhetetlen az eset-rohamkocsik, a mentőgépjárművek, illetve a gépjárműveken szükséges egészségügyi eszközök megfelelő színvonalon történő folyamatos biztosítása.

A bevételi előirányzat mértéke 22.313,0 millió forint, ami az előző évhez viszonyítva 1.461,5 millió forintos csökkenést jelent. 2.011,5 millió forint bevételkieséssel lehet számolni egyrészt a betegszállítási tevékenység részleges kiszervezése, ezzel összefüggésben az ellátandó feladatok és a hozzá kapcsolódó bevételek visszaesése miatt, másrészt az önkormányzatok csökkenő forrásaikra tekintettel, akik ezért várhatóan nem tudnak az előző évekhez hasonlóan hozzájárulni a mentőállomások építéséhez, felújításához, fenntartásához. A 2007. évben üzembe helyezett /új/ mentőállomások működtetése -az előző évhez képest- többletfeladatként jelentkezik, aminek bevétellel ellentételezett forrásigénye 550,0 millió forint.

A támogatási előirányzat mértéke 587,0 millió forint. Az előző évhez viszonyított 300,0 millió forintos többletet a légimentéssel összefüggő feladatok finanszírozására biztosított költségvetési támogatás jelenti.

A tervezhető létszámkeret 7.055 fő, a változás az új mentőállomások beindításával összefüggő 165 fő létszámfejlesztés eredménye.

7. cím Országos Vérellátó Szolgálat

Az Országos Vérellátó Szolgálat a vérellátás országos szerve, ami a Vérellátó Szolgálat Központjából, valamint a regionális vérellátó központokból és területi vérellátókból áll.
Az OVSZ feladata a regionális vérellátó központok munkájának koordinálása, a vérellátással kapcsolatos stratégiai tervezés ellátása, a vérkészítmények előállítása és kezelése, az országos vérkészletek nyilvántartása, diszpécserszolgálat működtetése, a transzfúziológiai kutatás-fejlesztés végzése, a transzfúziológiai képzés és továbbképzés irányítása.

Kiadásait közel 75 %-ban a vér- és vérkészítmények értékesítéséből származó bevételből biztosítja. A bevételi előirányzat 8.980,0 millió forint. A 360,0 millió forintos (47 fő létszám) növekedést az OGYK megszüntetése miatt a Diószegi úti telephelyen lévő Osztályok (Transzplantációs, Immunológiai Osztály, a Molekuláris Diagnosztikai Osztály stb) átvételének többlete jelenti.
A támogatási előirányzat 2.903,3 millió forint az előzős évhez képest 50,0 millió forintos növekedés, melyből a Transzplantációs Bizottság, a HLA Labor és a vesetranszplantációval összefüggő feladatok finanszírozása történik.

A feladatátvételt követően a létszámkeret 1.567 fő.

8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény elfogadásával 2007. január 1-i hatállyal (eredeti előirányzata 2007-ben a fejezeti kezelésű előirányzatok között szerepelt) megalakult a kormányhivatalként működő Egészségbiztosítási Felügyelet. A Hivatal az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők jogainak védelmével, a társadalombiztosítás körében egészségügyi és egészségbiztosítási szolgáltatást nyújtók szakmailag, minőségileg, a törvényeknek és az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők érdekeinek megfelelő működés ellenőrzésével, az ellátások – beleértve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátást is – nyújtásának biztosításával kapcsolatos feladatokat látja el.

A Felügyelet támogatási előirányzata 762,4 millió Ft, bevételi előirányzata 259,7 millió forint, a tervezhető létszámkeret 95 fő.

10. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi kiadási előirányzata 14.200,7 millió forint, melynek forrását 14.120,7 millió forint költségvetési támogatás és 80,0 millió forint bevétel biztosítja.

Az előirányzat alapvetően az egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok forrását biztosítja. Részét képezik a korábbi években megkezdett szakmai programok, különösen a népegészségügyi szűrővizsgálatok. Kiemelt támogatásban részesül a légimentés technikai feltételeinek biztosítása.
Az előirányzat tartalmazza a nemzetközi együttműködésből eredő kötelezettségeket, az ágazati információs feladatok forrását, az ágazati kutatásfejlesztéshez történő hozzájárulást.

10.1. Beruházások

10.1.1. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 2.500,0 millió Ft

Az Intézet átfogó rekonstrukcióját a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. tv. hagyta jóvá. A mintegy 33.000 m^2 bruttó szintterületű új épületegyüttes kivitelezése 2000. évben kezdődött el.

A beruházás finanszírozási alapokmányban rögzített összköltsége 13.879 millió Ft, mely összeg a befejezési határidő átütemezése miatt várhatóan módosul.

A program célja a korszerű, jól működő rehabilitációs tevékenység feltételrendszerének komplex módon való megteremtése, ezen belül:

- mozgássérült betegek rehabilitációjához szükséges alapterület biztosítása;
- speciális rehabilitációs szolgáltatások kialakítása;
- a kedvezőtlen terepviszonyok között szükséges belső szállítás csökkentése, a rehabilitációs szolgáltatások könnyebb elérhetősége céljából az intézet valamennyi funkciójának egy épületegyüttesbe telepítése;
- új profilként intenzív terápiás és – Magyarországon elsőként - kómaosztály kialakítása;
- a meglévő épületen belül a kórházi hotel és a rehabilitációs funkciók építészeti szétválasztása;
- ágyszám-csökkentéssel párhuzamosan a nappali kórházi ellátás fejlesztése.

Már 2006-ban építészeti szempontból elkészült a teljes beruházás 100 %-a. A szakipari munkák készültsége 85 %-ot ér el. Belső építészetileg elkészült a B. épület két szintje, mely területre két betegellátó osztály beköltöztetésre került.

A 2008-ra tervezett előirányzat felhasználásával folytatódhatnak a belsőépítészeti és alapgépészeti munkák.

1. „C” szárny: Teljes belső építészet, szakipari munkák: burkolatok, lakatos szerkezetek, álmennyezetek, belső nyílászárók, épületgépészeti szerelvények, festések, elektromos szerelvények, elosztók, légtechnikai szerelvények, automatikák, gyengeáramú szerelési munkák, tűzvédelmi, informatikai hálózatok és egyéb biztonságtechnikai rendszerek.
2. „C” szárnyi gépház üzembe helyezés: klíma automatika, légtechnikai befejező munkák.
3. „F” szárny tornaterem: Melegburkolatok, asztalos szerkezetek, belső nyílászárok, tűzjelző, informatika és telefonhálózat, szerelvények, árnyékoló rendszerek./
4. „E” szárny hidroterápiás részleg: Vízgépészet szerelés, üzembe helyezés, meleg burkolatok, asztalos szerkezetek, belső nyílászárók, lakatos szerkezetek, szerelvények, vizes-villamos, gyengeáram, tűzjelző, informatikai hálózat, telefon.

A rekonstrukció eredeti műszaki tartalommal való megvalósítása – orvostechnológia nélkül – a 2009-re tervezett előirányzatot is figyelembe véve 2009 első felében megtörténhet, a még hátralévő belső szerelési munkák, valamint külső környezetrendezés és bontási munkák elvégzésével.

10.1.7. Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója 50,0 millió Ft

A beruházás orvos-szakmai és gazdasági-műszaki jóváhagyása 2000. évben történt azzal, hogy a megvalósítás két ütemben történik.

A beruházás I. ütemének szakmai tartalma a következő:

- 50 ágyas sportsebészeti osztály
- 8 ágyas fektető és 4 ágyas szubintenzív osztály
- 2 db aszeptikus és 2 db 1 napos sebészeti műtő
- járóbeteg szakellátás
- központi diagnosztikai egység (röntgen, klinikai laboratórium)
- központi ellátó-részlegek (sterilizáló, öltözők, tálalókonyha)

Az I. ütem 5.251 millió Ft építési – gép-műszer nélkül számított – költségű beruházása 2002. májusában kezdődött. Az eredetileg tervezett befejezési határidő 2004. I. féléve volt.

A finanszírozási ütemek módosulása miatt 2004. év végéig – 2,2 milliárd Ft költséggel – elkészült:

- teljes szerkezetépítési munka
- tetőszigetelési munka
- homlokzati üvegfalak és nyílászáró szerkezetek beépítése
- épületgépészeti alapvezetékek beszerelése
- végleges homlokzat kiképzés (hőszigeteléssel és szerelt kőburkolattal)

Az épület ezzel 50 %-os építési készültségi fokot ért el és a külső időjárási viszonyoktól védetté vált.
2005. évtől állagvédelmi és vagyonőrzési feladatok ellátására került sor.

2008. évben változatlanul a beruházás állagvédelmi és vagyonőrzési feladataival számolunk és továbbra is keressük a külső tőke bevonásával történő befejezés lehetőségét.

A központi intézetek struktúra átalakítása keretében egyéb vagyonhasznosítási lehetőségek megvalósítását is mérlegeljük.

10.1.8. Egyéb intézményi beruházások
50,0 millió Ft

Az előirányzat felhasználás tervezett célja változatlanul a felügyeleti hatáskörbe tartozó intézmények - vis-mayor helyzet - okozta és a működési feltételek biztosítása szempontjából nélkülözhetetlen orvosi gép-műszerek cseréinek finanszírozása.

10.2. Egészségügyi ágazati célelőirányzatok

10.2.1. Oltóanyag beszerzés
4.500,0 millió Ft

Az ÁNTSz a védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségeit, köztük a védőoltások tervezésének, és az egyes oltóanyagok beszerzésének feladatait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény, valamint annak felhatalmazása alapján a népjóléti miniszter a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) számú rendelete alapján látja el.

A hivatkozott jogszabályoknak megfelelően az ÁNTSz-nek kell beszerezni és zökkenőmentesen, térítésmentesen biztosítani:
- az életkorhoz kötötten kötelező védőoltásokat,
- a megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokhoz szükséges oltóanyagot,
- valamint a veszélyeztetettek részére az influenza elleni oltóanyagot.

2006. évben döntés született, hogy a kötelező védőoltások folyamatos biztosítása, illetve a szakma által meghatározott követelmények teljesítése érdekében egy hosszabb távú – öt évre szóló – tender kerüljön kiírásra. A pályázaton nyertes cég. az éves mennyiség teljes leszállítását követően 400 nap fizetési haladékot biztosított a számlák kiegyenlítésére.
Az előirányzat a 2008. évben esedékes fizetési kötelezettségének fedezetét biztosítja.

10.2.2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
1.966,7 millió Ft

E feladatcsoportba tartoznak a tárca számára korábbi években is kiemelt fontossággal bíró programok. Az ellátási és fejlesztési források között jelenítjük meg többek között a népegészségügyi programmal, az ágazati információs programokkal, az ágazati kutatásfejlesztéssel, a nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos feladatok forrásait.

Népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok
483,0 millió forint

2008-ban is folytatódnak a szervezett lakossági daganatszűrések (emlőszűrés, méhnyakszűrés), valamint folytatódnak a „pilot" programok a vastagbél- és végbélrák, valamint az ajak és szájüregi rákok korai felismerését célzó szűrővizsgálatok esetében.
Kiemelt jelentőségű a hátrányos helyzetű, főleg roma gyermekek szűrésének támogatása.
A szűrővizsgálatok célja a korai, tünetmentes szakban lévő, még eredményesen gyógyítható esetek felismerése, az Európai Unió átlagát jelentősen meghaladó magyarországi rákos halálozás csökkentése.
Összhangban a Nemzeti AIDS stratégiával további feladat a lakossági tájékoztatáson és képzésen túl, a célzott megelőzési programok által csökkenteni a fokozott kockázatnak kitettek körében a HIV/AIDS járvány terjedésének veszélyét.
Kiemelt jelentőségűek a gyermekegészségügyi programok, különösen a fiatalok egészségesebb életmódjának kialakításához, az elhízás visszaszorítása érdekében indított programok támogatása.

Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételinek javítása
171,0 millió forint

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 230. §-a értelmében a katasztrófa-egészségügyi ellátás biztosítása és finanszírozása állami feladat. Az ellátás biztosításának kötelezettsége magába foglalja az erre történő felkészülési tevékenység, valamint a tényleges működés megszervezését és lebonyolítását. Ennek része az egészségügyi készletek tartalékolása, az OMSZ katasztrófa reagáló képességének fokozása (Tömeges Baleseti Egység), valamint a katasztrófa-egészségügyi ellátási gyakorlatok végrehajtása.

HEF-OP egészségügyi intézkedései technikai lebonyolítás támogatása
50,0 millió Ft

Az előirányzat tervezését az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és a Kohéziós Alapból származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet, a 10/2004. (IV. 7.) FMM-ESZCSM együttes rendelet, valamint a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága Működési Kézikönyve határozza meg.

Az előirányzat felhasználásának célja a TÁMOP, TIOP, KMOP és HEFOP egészségügyi intézkedéseinek hatékony és szakszerű, átlátható végrehajtása, a projektek megvalósításának irányítása és támogatása.

Az előirányzat a Közösségi Támogatási Keret Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjához (NFÜ fejezet), valamint az Operatív Program Irányító Hatósága feladatainak ellátásához kapcsolódik, biztosítja a Programiroda, mint Közreműködő Szervezet egyéb forrásból nem finanszírozható működési és egyéb kiadásainak fedezetét.

NFT II. tervezési feladatai
12,0 millió Ft

Az előirányzat felhasználásának célja az Egészségügyi Minisztérium által - tekintettel arra, hogy 2008. évben is folytatni kívánja a felkészülést a 2007-2013 EU programozási időszakra - a Nemzeti Fejlesztési Terv II kidolgozása során elkészített operatív programokhoz kapcsolódó Akciótervek kidolgozásának, és a pályázati dokumentációk elkészítésének támogatása. Ezzel párhuzamosan ezek egyeztetése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, és a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal.
A feladatok elvégzéséhez szakértők megbízása, műhelymunka elvégzése, háttértanulmányok feldolgozása és adatgyűjtése, szakmai fórumok és konferenciák megszervezése, valamint kiadványok, véleményezések készíttetése szükséges.

Nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek
109,0 millió Ft

A tárca széles körben lát el szakmai, koordinációs feladatokat, mind európai uniós tagságunkból eredően, mind pedig a sokoldalú és a kétoldalú kormányközi együttműködések tekintetében.
A tárca az előirányzat terhére finanszírozza az EU tagságból eredő, széles körben jelentkező egészségügyi feladatok ellátását, a kormányközi nemzetközi szervezetekben - kiemelten az Egészségügyi Világszervezetben, az Európa Tanácsban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) - Magyarország tagságából eredő, az egészségügy területén meglévő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kiadásokat, a kétoldalú kapcsolatainkból eredő kötelezettségeinkhez kapcsolódó feladatokat, kiemelten az államközi kétoldalú szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények előkészítéséből, aláírásából, végrehajtásából, felülvizsgálatából, továbbá a kormányközi vagy tárcaközi egészségügyi együttműködési megállapodások előkészítéséből, végrehajtásából adódó feladatokat, az Egészségügyi Reform kialakításával, fejlesztésével és alkalmazásának nemzetközi vetületével összefüggő koordinációs és logisztikai feladatok ellátását (fordítások, szakértők meghívása, tárgyalások).

A kötelezettségek ellátásához biztosítani kell az EU tagságból eredő ügyek intézéséhez szükséges személyi feltételeket, (szaktanácsadás, szakértői tevékenység végzése, egyedi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések, vállalkozói szerződések), külföldi kiküldetéseket, az EU tagállamaként való működéshez kapcsolódó, valamint a sokoldalú és kétoldalú kormányközi együttműködések ellátása technikai feltételeit (fordítások, tolmácsolások, kiadványok, adatbázisok vásárlása, magyar kiadványok készítésének támogatása, stb), az együttműködésekhez kapcsolódó hazai rendezvények szervezését (magyarországi rendezvények, konferenciák, munkacsoport ülések rendezése, szükségessé váló intézményi támogatások finanszírozása), a kétoldalú együttműködések keretében külföldi delegációk, szakértők fogadását.

Egyéb egészségpolitikai feladatok
147,0 millió Ft

Az előirányzat fedezetet biztosít a betegek biztonságának erősítésére, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti és szakmai feladatainak minőségfejlesztését szolgáló integrált rendszerek kialakítására. Megvalósítandó cél, hogy minden magyar állampolgár a számára szükséges ellátást közel hasonló ellátási színvonalon kapja meg. Ehhez szükség van a szolgáltatók minőségirányítási rendszerének fejlesztésére, a szolgáltatók folyamatos, objektív adatokon alapuló összehasonlítására, illetve az értékelési rendszerekkel és az értékelést végzőkkel szembeni követelmények egységesítésére. Szükséges kialakítani a speciális szolgáltatást végzők akkreditálási rendszerének követelményeit, valamint a minősítés szervezeti lehetőségét.
Az előirányzat terhére történik továbbá a népegészségügyi, környezet-egészségügyi, epidemiológiai egészségfejlesztési, egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési posztgraduális szakirányú továbbképzés, valamint a Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) működésének továbbá szerv- és szövetadományozás esetén a donorok jogszabályban meghatározott költségeinek biztosítása.

Ágazati kutatásfejlesztés
80,0 millió Ft

A magas szintű betegellátás és felsőfokú képzés fenntartásának alapja a kutatásfejlesztés és a nemzetközi szinten elismert, kifejlesztett, új, klinikai kutatási eredmények befogadása, mielőbbi hazai alkalmazása. Az Európai Unió különböző kutatásfejlesztési elképzeléseiben az egészségügy mellett a biotechnológia, a környezetvédelem fontos prioritás, melyek közül a két utóbbi is az egészségügy fejlesztését, védelmét szolgálja.
Az ágazati kutatásfejlesztésnél is ezt a célt tűzte ki a tárca, figyelemmel az új eljárások bevezetésének segítésére, az adaptációs klinikai kutatások kiemelésével. A szakmai előrehaladásban nélkülözhetetlen az új diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetése.

Egészség-kommunikáció (tárcakommunikáció)
100,0 millió Ft

Az egészségügyi reform elfogadottságának növelése 2008-ban is intenzív kommunikációs tevékenységet igényel.
Az előirányzatból a tárca nagy olvasottságú országos napilapokban teljes oldalas egészségügyi melléklet megjelenését, szemléletformáló és a reformlépések elfogadottságát növelő kampányok (honlapfejlesztés, rádió és tv-spotok, hirdetések, rendezvények szervezése) költségeit, összefoglaló kiadványok, szórólapok egészségügyi intézményekben történő terjesztését finanszírozza.

Ágazati információs programok
70,0 millió Ft

Az előirányzatból a tárca fedezetet biztosít a TIOP és TÁMOP keretén belül történő ágazati informatikai fejlesztések hatékony elindítását megalapozó előtanulmányok elkészítésére, a lakossági és ágazati információ szolgáltatás, ügyintézés elősegítésére. Az előirányzat forrást biztosít az egységes egészségügyi elektronikus információáramlás szabványainak elkészítésére, naprakésszé tételére, a szükséges szabványügyi díjak befizetésére, az informatikai szakmai szervezetek (pl. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság) tagdíjára. Biztosítja továbbá az operatív programok keretein belül nem megvalósítható, de azok eredményességét elősegítő, kiegészítő pilot projektek fedezetét, valamint az ágazati stratégia véglegesítéséhez szükséges szakértői díjakat.

Szerkezet/intézmény átalakítás és intézmény felügyeleti feladatok
715,9 millió Ft

Az Államháztartási törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletek, a kincstári vagyon védelmét szabályozó jogszabályok a tárca számára több olyan kötelezettséget írnak elő, melyek a minisztérium által felügyelt intézmények vonatkozásában a tulajdonosi, fenntartói kötelezettségekkel függnek össze.

Az ellátórendszer fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok a tárca felügyelete alá tartozó intézetekben is jelentős átalakításokat igényelnek. Az egyes átcsoportosításra kerülő feladatok befogadásának feltételeit biztosítani kell.

A megszüntetendő intézményekkel kapcsolatos jogutódlási feladatok forrásigénye előre láthatóan 600,0 millió Ft. Gondoskodni kell mintegy 12 500 iratfolyóméter dokumentáció adatvédelmi szempontoknak megfelelő elhelyezéséről. Fokozott vagyonvédelmi szempontok szerint kell gondoskodni az ingatlanok és eszközök őrzéséről, meg kell szervezni és biztosítani kell a használaton kívüli készletek megfelelő hasznosítását az érdekeltek számára hozzáférhető „börzék” szervezésével. Gondoskodni kell továbbá a feleslegessé vált készletek selejtezéséről illetve szakszerű tárolásáról. A megszűnt intézmények vagyoni vonatkozású jogutódja az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet. A jogutódlással összefüggő feladatok (pl.: peres ügyek

továbbvitele, a vagyon állagmegóvása, stb.) megfelelő apparátus és anyagi források rendelkezésre állását kívánja meg.

A fenntartóknak gondoskodni kell a likviditási problémákkal küzdő intézmények helyzetének javításáról, az egyes intézményi átszervezések okozta többletköltségek biztosításáról, a saját hatáskörben elrendelt létszámleépítések többletköltségeinek fedezetéről, a vagyonvédelemmel, vagyonértékesítéssel összefüggő többletfeladatok (pl. vagyonértékelés) költségeinek biztosításáról, valamint a helyes gazdálkodásról, melyet szabályzatban kell rögzíteni. E sorról kell biztosítani az intézmény-felügyelettel kapcsolatos jogi-pénzügyi szakértői tevékenységek fedezetét is.

Energiaár adóemelés kompenzációja
18,8 millió Ft

Az előirányzat a fejezet felügyelete alá tartozó központi költségvetési szerveket 2008. évben terhelő energiaadó emelés kompenzációjául szolgál. A támogatás intézményekre történő leosztása a 2006. évben elszámolt gáz- és villamos energia szolgáltatás arányában történik.

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
10,0 millió Ft

Az előirányzat a peres eljárásokkal kapcsolatban felmerülő kiadások pénzügyi fedezetére szolgál. Pénzügyi fedezet biztosítja a tárca vezetője által képviselt Magyar Állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben, vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott összegek, továbbá a perrel kapcsolatos eljárási költségek (ügyvédi, bírósági díjak stb.) megtérítését.

10.2.3. Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások
800,0 millió Ft

2005. évben a Kormány határozatban döntött a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről, így az önálló, légimentésért felelős közhasznú társaság létrehozásáról, új helikopterek beszerzéséről, valamint a légimentés folyamatos finanszírozásának biztosításáról [a magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005 (VII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)].
2005 novemberében megalakult az új, 100 %-ban az Országos Mentőszolgálat – így az állam – tulajdonában lévő Légimentő Kht., majd a nemzetközi közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a tender nyertese, és így a szerződött partner az osztrák HeliAir Gmbh. lett, amely az osztrák autóklubbal (ÖAMTC) Európa egyik legnagyobb egységes légimentő-helikopter flottáját tulajdonló és üzemeltető cége. A közbeszerzési eljárás eredményének megfelelően öt gép bérlése a szerződés értemében határozott időre – 10 évre – került meghatározásra.
Ez az öt bérelt gép – a nagyjavításon átesett három saját tulajdonú helikopterrel együtt – képes lesz arra, hogy Magyarország területét a lehető legnagyobb mértékben lefedje,

lehetővé téve ezzel a lakosság csaknem egészének a 15 percen belüli mentéshez való hozzáférését, biztosítva az esélyegyenlőséget.
A fentiek értelmében az előirányzat az 5 db osztrák helikopter bérleti díjának, valamint a légimentéssel (eszközparkkal, légimentő-bázisokkal) kapcsolatban, év közben a vis maior helyzetek miatt felmerülő rendkívüli kiadásoknak a biztosítását szolgálja.

10.2.4. Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok 150,0 millió Ft

A egészségügyi reform intézkedéseinek folyamatos figyelemmel kísérése, a változások, eredmények értékelése, a szükséges módosításokra tanulmányok, javaslatok készítése, kommunikációja az elkövetkezendő időszak feladata.

Az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartási folyamatának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet alapján a természetbeni egészségügyi szolgáltatások finanszírozási díjparamétereinek karbantartását rendszeresen el kell végezni. A miniszteri rendelet szabályozza a díjparaméterek karbantartásában közreműködő szervezetek feladatait, az alapvető feladatokat, a kalkulációs szabványokat.
A díjparaméterek karbantartása biztosítja az átlátható, igazságos, normatív, költséghatékony, költségkorlátos finanszírozás megvalósítását. Ennek érdekében folyamatosan felülvizsgálják és meghatározzák az egészségügyi szolgáltatók teljesítmény elszámolásában alkalmazandó finanszírozási díjparamétereket.

10.2.9. Altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások 1.250,0 millió Ft

Az aneszteziológiai géppark megújítása érdekében a Kormány 2207/2005. (X.5.) Korm. határozatában megfogalmazott döntésének megfelelően az egészségügyi miniszter az állam nevében aláírt 8 éves futamidejű tartós bérleti konstrukciót tartalmazó szerződés alapján 2006-ban 319 db. altatógépet, 416 db. lélegeztetőgépet és 544. db. monitort szerzett be. A gépek használatra 109 egészségügyi intézethez kerültek. A bérleti díjat minden évben a fejezet költségvetése tartalmazza.
A fentiek értelmében az előirányzat a 2008. évi eszközbérlet díjának, valamint az eszközparkhoz kapcsolódó egyéb (eszközparkkal kapcsolatos ellenőrzési, adatszolgáltatási, jelentési,) feladatok miatt felmerülő kiadásoknak, valamint az intézmény-átszervezések következtében az eszközátadások miatt felmerülő és a tárcát érintő költségeknek a biztosítását szolgálja.

10.2.11. Regionális ágazati feladatok ellátása 35, 0 millió Ft

Az egészségügyi kapacitás-szabályozás és felülvizsgálati eljárás megvalósítása során a Regionális Egészségügyi Tanácsoknak önálló kapacitás-elosztás javaslattételi, tervezési feladatai vannak, melynek keretében regionális kapacitás felosztási tervet kell készíteniük. A támogatás célja az e feladatokhoz kapcsolódó tervező munka elvégzésének támogatása.

Az Egészségügyi Minisztérium NFT II. keretében tervezett fejlesztéseinek, pályázati kiírásainak kellő mértékű területi, kapacitásbeli megalapozása érdekében a Regionális Egészségügyi Tanácsok által regionális felmérések, tanulmányok elkészítése, a kapcsolódó tervezői munka elvégzésének támogatása.
A feladatok ellátáshoz és a forrás felhasználásához a Regionális Egészségügyi Tanács szakértőinek megbízása szükséges.

10.2.12. Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 80,0 millió Ft

A keret felhasználásának célja a külföldön élő, magyar nemzetiségű külföldi állampolgároknak meghatározott egészségügyi intézményekben Magyarországon történő gyógykezelési költségeihez való hozzájárulásának biztosítása.
A támogatási összeg felhasználása:
- a rendelkezésre álló forrás 7%-a az Egészségügyi Minisztérium megvalósításában a Bizottság működésére, valamint a Központi Irodákon működő értékelő szakfelügyelő főorvosok megbízásos jogviszonyára kerül felhasználásra.
- a rendelkezésre álló forrás 93%-a az Országos Egészségbiztosítási Pénztár megvalósításában kerül felhasználásra. A forrás a külföldön (Szerbiában és Ukrajnában) élő, magyar nemzetiségű külföldi állampolgároknak meghatározott magyar egészségügyi intézményekben történő gyógykezelési költségeihez való hozzájárulásra, a betegellátással szorosan összefüggő betegszállítási költség biztosításának támogatására, továbbá az OEP részére a feladat ellátásához szükséges működés (adminisztráció, nyilvántartás, ellenőrzés, postaköltség stb.) biztosítására kerül felhasználásra az alábbi feltételek mellett:

- Az OEP a minisztérium által elfogadott ellenőrizhető eljárás rend alapján biztosítja a Bizottság döntése alapján meghatározott intézmények részére az ellátás támogatását.
- A támogatás biztosítására kizárólag azon határon túli magyarok jogosultak, akik nem az Európai Uniós tagállamok állampolgárai.
- A forrásból nem támogatható az egyéb nemzetközi kötelezettség alapján történő egészségügyi ellátás.

10.2.13. Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 530,0 millió Ft

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 41. § (1) bekezdése szerint, olyan gyógyszertárat működtető vállalkozás számára, ahol a település gyógyszerellátását az adott közforgalmú gyógyszertár egyedül biztosítja és – tekintettel az ellátandó lakosságszámra, földrajzi elhelyezkedésre – a gyógyszerforgalmazásból származó árrés bevétele hatékony gazdálkodás mellett is rendkívül alacsony, az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben az EüM fejezetében meghatározott előirányzat erejéig, a működőképesség fenntartásához támogatást nyújt. A támogatás az Art. szerint költségvetési támogatásnak minősül.

A támogatás feltételeit és formáit külön jogszabály tartalmazza. E szerint a támogatás lehet:
– árrés alapú (6 havi árréstömeg 12 millió forint alatt, egyedüli gyógyszertár a településen, heti 40 óra nyitva tartás),
– fiókgyógyszertár működtetésének támogatása (6 havi árréstömeg 25 millió forint alatt és fiókgyógyszertárat működtet),
– helyettesítési támogatás (egyedüli gyógyszertár a településen, heti 40 óra nyitva tartás, egy gyógyszerész).

10.2.41. Intézményi felújítás
200,0 millió Ft

A teljes előirányzatot a fejezethez tartozó intézmények működésének tárgyi feltételeiben bekövetkező változások helyreállítására tervezezzük.

A meghibásodásokat követő helyreállító beavatkozásokat elsősorban az épületgépészeti rendszerek esetében tervezzük finanszírozni. Ezek sorában kiemelten kezeljük a hő- és villamosenergia ellátó rendszereket, továbbá a beteg- és személyszállító felvonók és tűzvédelmi berendezések üzembiztonságát.

10.11.1. Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatása
205,0 millió Ft

Magyarország 2008. évi tagdíjfizetési kötelezettségei 2007. évhez képest 100%-kal emelkedtek. Az előirányzat terhére történik Magyarország tagdíjfizetési kötelezettsége az Egészségügyi Világszervezet részére, az egyéb kormányközi szervezetek – egyes, a tárca tevékenységét érintő ENSZ, illetve ahhoz kapcsolódó szervezetek – tevékenységében való részvétel támogatása, az Európa Tanács Európai Gyógyszerkönyve költségvetéséhez történő hozzájárulás fizetése, a Rotterdami PIC Egyezmény titkársága működési költségeihez való hozzájárulás elszámolása, az ENSZ EGB Víz és Egészség tagdíj hozzájárulás, OECD Control of Chemicals tagdíj hozzájárulás, WHO Dohányzás-ellenőrzési keretegyezményhez való magyar hozzájárulás, a Magyar Rákellenes Ligának a Nemzetközi Rákellenes Ligában (UICC) való részvételére vonatkozó tagdíja.

10.17.1. Magyar Orvosi Kamara támogatása
10,0 millió Ft

Az előirányzat a 2007. április 1-től hatályba lépett kamarai törvényben meghatározott alábbi közfeladatok megvalósítására kerül felhasználásra:
- A továbbképzés szervezését koordináló országos iroda működtetése.
- Az etikai bizottságok működtetése.

10.17.2. Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása
10,0 millió Ft

Az előirányzat a Magyar Gyógyszerész Kamara által 2007. április 1- től ellátandó alábbi közfeladatok megvalósítására kerül felhasználásra:

- Etikai normák megalkotása és megsértőinek szankcionálása.
- A kamarai tagok felvételével, felfüggesztésével és kizárásával összefüggő feladatok, nyilvántartás vezetése.
- A tagjai körében szervezett továbbképzés szakmai feltételinek, egységes elveinek és programjainak meghatározása,
- Az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékének közzététele.

10.17.3. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása
15,0 millió Ft

Az előirányzat a 2007. április 1-től hatályba lépett kamarai törvényben meghatározott alábbi közfeladatok megvalósítására kerül felhasználásra:

- Etikai normák megalkotása és megsértőinek szankcionálása.
- A tagjai körében szervezett továbbképzés szakmai feltételinek, egységes elveinek és programjainak meghatározása.
- Az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékének közzététele.

10.20.10. Magyar Vöröskereszt támogatása
200,0 millió Ft

A Magyar Vöröskereszt az 1993. évi XL. törvényben foglaltak alapján sokrétű, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket végez:

- egészségvédelmi programok, szűrővizsgálatok, felvilágosító rendezvények szervezése,
- véradói hálózat szervezése, véradás lebonyolítása,
- menekültügyi tevékenység folytatása,
- jelentős szerepvállalás a katasztrófa elhárításában, a károsultak megsegítésében,
- az elsősegélynyújtás oktatása,
- önkéntesek képzése,
- szociális tevékenység, szociális intézmények működtetése.

Az előirányzat felhasználásának célja: A Vöröskereszt működésével kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás, a kiemelt központi és koordinációs feladatok ellátása és működtetése, nemzetközi kapcsolattartás, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok ellátása, működtetése.
A Magyar Vöröskereszt tevékenységei közül kiemelendő az egészségfejlesztési programok, véradások szervezése, a tárca prioritásai közé tartozó szűrővizsgálatok lebonyolítása.

10.20.11. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása
15,0 millió Ft

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége az orvosok és fogorvosok szakmai és tudományos egyesületei és társaságai, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó természet- és társadalomtudományi társaságok és egyesületek társulásán alapuló szövetség.
A Szövetség számára a költségvetésből megállapított keret a vezető testületek, szakmai bizottságok (orvosszakmai és érdekképviseleti; szakmapolitikai és finanszírozási; képzési és tudományos; alapellátási; informatikai; rehabilitációs bizottság) működését szolgálja.

10.20.18. Rákbetegek szervezeteinek támogatása
45,0 millió Ft

A Rákbetegek Országos Szövetsége a rákbetegek országos érdekképviseleti szervezete. Tevékenységével sokoldalúan szolgálja a rákbetegek gyógyulását, jobb életminőségét, társadalmi rehabilitációját. Segíti a betegek tájékoztatását, egészségnevelését. Az ország területén 78 tagszervezete és 5 Napforduló Segítő Szolgálata működik.

A Magyar Rákellenes Liga célja tudatosítani az emberekben, hogy cselekvéssel, tenniakarással a rák elkerülhető, legyőzhető. Rendezvényeivel felhívja a figyelmet a betegség megelőzésének lehetőségeire, a szűréseken való részvétel fontosságára. Kiemelt feladata a betegek lelki támogatása, a rehabilitáció elősegítése, a betegtájékoztatás.

A Magyar ILCO Szövetség célja a sztómával élők érdekvédelme, összefogása és segítése, utóápolásuk megszervezése, egészségvédelmi továbbképzése, rehabilitációjuk elősegítése, szociális ügyekben tanácsadás, ügyintézés.

10.20.1. Fejezeti tartalék
20,0 millió Ft

Az előirányzat az ágazatban év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadásokra nyújt fedezetet.

10.22.2. Fejezeti egyensúlyi tartalék
1.569,0 millió Ft

Dr. Horváth Ágnes
egészségügyi miniszter

Dr. Veres János
pénzügyminiszter